



Meu Rim - Pacote CEAF / SESAB

Documentos oficiais para implementacao do modulo LME/CEAF - Bahia

ATENCAO: esta pagina e apenas um indice. Os formularios oficiais seguem sem redesenho.

1. LME oficial SESAB/CEAF 2026

Formulario comum aos processos abaixo.

2. Anemia na DRC - Alfaepoetina

TER oficial + formulario medico oficial.

3. Anemia na DRC - Reposicao de ferro IV

TER oficial do sacarato de hidroxido ferrico + formulario medico oficial.

4. Disturbio Mineral Osseo na DRC

TER oficial + formulario de solicitacao de medicamentos (2 paginas).

5. Sindrome Nefrotica Primaria em Crianças e Adolescentes

TER oficial + formulario de acesso.

6. Lupus Eritematoso Sistêmico (inclui fluxo usado para comprometimento renal quando aplicável)

TER oficial (2 paginas) + formulario de acesso (3 paginas).

7. Declaracao de residencia de terceiro - CEAF

Documento complementar opcional quando o comprovante esta em nome de terceiro.

Regra para o desenvolvimento:

O aplicativo deve preencher os PDFs oficiais; nao deve recriar LME, TER ou formulario estadual.

A receita pode ter layout proprio do Meu Rim, mas medicamento, CID, dose e quantidade devem ser unicos.

Fontes oficiais SESAB/BA consultadas em 11/08/2026. Transplante nao esta incluido neste pacote.



Sistema Único de Saúde
Ministério da Saúde
Secretaria de Estado da Saúde

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTO(S)

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO(S)

CAMPOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO MÉDICO SOLICITANTE

1-Número do CNES* 2- Nome do estabelecimento de saúde solicitante

3- Nome completo do Paciente* 5-Peso do paciente* kg

4- Nome da Mãe do Paciente* 6-Altura do paciente* cm

7- Medicamento(s)*		8- Quantidade solicitada*					
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1							
2							
3							
4							
5							
6							

9- CID-10* 10- Diagnóstico

11- Anamnese*

12- Paciente realizou tratamento prévio ou está em tratamento da doença?* ☐ NÃO ☐ SIM. Relatar:

13- **Atestado de capacidade***
A solicitação do medicamento deverá ser realizada pelo paciente. Entretanto, fica dispensada a obrigatoriedade da presença física do paciente considerado incapaz de acordo com os artigos 3º e 4º do Código Civil. O paciente é considerado incapaz?
☐ NÃO ☐ SIM. Indicar o nome do responsável pelo paciente, o qual poderá realizar a solicitação do medicamento
Nome do responsável

14- Nome do médico solicitante* 17- Assinatura e carimbo do médico*

15- Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do médico solicitante* 16- Data da solicitação*

18 - **CAMPOS ABAIXO PREENCHIDOS POR***: ☐ Paciente ☐ Mãe do paciente ☐ Responsável (descrito no item 13) ☐ Médico solicitante
☐ Outro, informar nome: e CPF

19- Raça/Cor/Etnia informado pelo paciente ou responsável* ☐ Branca ☐ Amarela ☐ Preta ☐ Indígena. Informar Etnia: ☐ Parda

20- Telefone(s) para contato do paciente

21- Número do documento do paciente ☐ CPF ou ☐ CNS

22- Correio eletrônico do paciente

23- Assinatura do responsável pelo preenchimento*

* CAMPOS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO



Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde - SAFTEC

Diretoria de Assistência Farmacêutica – DASF

Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada - COAFE

TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE

Anemia em paciente com insuficiência renal crônica

ALFAEPOETINA

Eu, _____ (nome do(a) paciente), declaro ter sido informado(a) claramente sobre os benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso do medicamento alfaepoetina, indicado para o tratamento da anemia na doença renal crônica. Os termos médicos me foram explicados e todas as minhas dúvidas foram resolvidas pelo médico _____ (nome do médico que prescreve).

Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o medicamento que passo a receber pode trazer os seguintes benefícios:

correção da anemia e consequente redução da necessidade de transfusões;- melhora sintomática e da qualidade de vida;

redução no número de hospitalizações;

melhora da capacidade cognitiva e do desempenho físico.

Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos:

Não se sabe ao certo os riscos do uso da alfaepoetina na gravidez; portanto, caso engravide, devo avisar imediatamente ao meu médico;

os efeitos adversos mais comumente relatados são os seguintes: tonturas, sonolência, febre, dores de cabeça, dores nas juntas e nos músculos, fraqueza e aumento da pressão arterial. Também podem ocorrer problemas graves no coração, como infarto do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais (derrame), além da formação de trombos. Ausência da produção de células vermelhas do sangue foi relatada raramente após meses a anos de tratamento com alfaepoetina; reações no local da injeção, como queimação e dor, podem ocorrer, mas mais frequentemente em pacientes que receberam o medicamento por via subcutânea que por via intravenosa;

O medicamento está contraindicado em casos de hipersensibilidade (alergia) a ele ou aos componentes da fórmula e em casos de pressão alta não controlada; O risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem.

Estou ciente de que esse medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não queira ou não possa utilizá-lo ou se tratamento for interrompido. Sei também que continuarei a ser atendido, inclusive se desistir de usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que assegurado o anonimato.

() Sim () Não

Nome do paciente: _____		Data: ____ / ____ / ____	
Nome do responsável legal: _____		CPF Nº : _____	
_____ Assinatura do paciente ou do responsável legal			
Médico Responsável: _____	CRM: _____	UF: _____	
_____ Assinatura e carimbo do médico			

Observação: Este Termo é obrigatório ao se solicitar o fornecimento de medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e deverá ser preenchido em duas vias: uma será arquivada na farmácia, e a outra, entregue ao usuário ou ao seu responsável legal.



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB
Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde - SAFTEC
Diretoria de Assistência Farmacêutica - DASF
Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada - COAFE

FORMULÁRIO MÉDICO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS - TRATAMENTO DE ANEMIA NA DOENÇA RENAL CRÔNICA

Nome do Paciente: _____	Data do Atendimento: ____/____/____
Serviço: _____	Cidade: _____
Médico Responsável: _____	CRM: _____ UF: ____
CID-10: () N18.0 ou () N18.8	

Medicamento Solicitado: _____

POR DEFICIÊNCIA DE ALFAEPOETINA PORTARIA SAS/MS N° 365 DE 15/02/2017

Diagnóstico de doença renal crônica (DRC) e as condições 1+2+3 + (4 ou 5), assinar abaixo:

- () 1. DRC nos estágios 3-5 (taxa de filtração glomerular estimada (TFG) < 60 mL/min por 1,73 m²).
- () 2. Anemia com Hemoglobina ≤ 10 g/dL (adultos) ou < 11 g/dL (pacientes pediátricos até 18 anos).
- () 3. Índice de Saturação da Transferrina (IST) > 20 %.
- () 4. Hemodiálise com Ferritina > 200 ng/mL.
- () 5. Tratamento Conservador ou Diálise Peritoneal com Ferritina > 100 ng/mL.

Anexar: Creatinina (validade: semestral); Hemoglobina (validade: mensal); Ferritina (validade: trimestral); Índice de Saturação da Transferrina (IST) (validade: trimestral).

POR DEFICIÊNCIA DE SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO - PORTARIA SAS/MS N° 365 DE 15/02/2017

Diagnóstico de doença renal crônica (DRC) e as condições 1+2+(3 ou 4 ou 5 ou 6) conforme assinalado abaixo:

- () 1. DRC nos estágios 3-5 (taxa de filtração glomerular estimada (TFG) <60 mL/min por 1,73m²). ()
- () 2. Anemia com hemoglobina <10 g/dL.
- () 3. Tratamento conservador ou diálise peritoneal com ferritina <100 ng/mL e índice de saturação da transferrina (IST) <20% (deficiência absoluta).
- () 4. Tratamento conservador ou diálise peritoneal com ferritina entre 100 e 500 ng/mL e índice de saturação da transferrina (IST) <20% (deficiência relativa).
- () 5. Hemodiálise com ferritina <200 ng/mL e índice de saturação da transferrina (IST) <20% (deficiência absoluta).
- () 6. Hemodiálise com ferritina entre 200 e 500 ng/mL e índice de saturação da transferrina (IST) <20% (deficiência relativa)

Anexar: Creatinina (validade: semestral); hemoglobina (validade: mensal); ferritina (validade: trimestral); índice de saturação da transferrina (IST) - (calculável pelo ferro sérico e pela capacidade total de ligação do ferro - validade: trimestral).

PACIENTES PEDIÁTRICOS ATÉ 18 ANOS

Diagnóstico de doença renal crônica (DRC) e as condições 1+2+3, conforme assinalado abaixo:

- () 1. DRC nos estágios 3-5 (TFG <60 mL/min por 1,73m²).
- () 2. Anemia com hemoglobina <10 g/dL.
- () 3. Ferritina <200 ng/mL e índice de saturação da transferrina (IST) <20%.

Anexar: Creatinina (semestral); hemoglobina (mensal); ferritina (trimestral); IST (trimestral).

Declaro para fins de solicitação dos medicamentos Alfaepoetina e ou Sacarato de Hidróxido Férrico para o tratamento de Anemia na Doença Renal Crônica, que o (a) paciente não apresenta nenhum critério de exclusão para uso do ou do(s) medicamento(s) indicado(s).

Assinatura e carimbo do(a) médico(a)



TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE
ANEMIA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA - REPOSIÇÃO DE FERRO
SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO

Eu, _____ (nome do(a) paciente), declaro ter sido informado(a) claramente sobre os benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso do medicamento sacarato de hidróxido férrico, indicado para o tratamento da anemia na doença renal crônica. Os termos médicos foram explicados e todas as minhas dúvidas foram resolvidas pelo médico _____ (nome do médico que prescreve). Assim declaro que fui claramente informado(a) de que o medicamento que passo a receber pode trazer o seguintes benefícios:

⌚ Melhora da anemia e, conseqüentemente, melhora da capacidade funcional, qualidade de vida e redução da morbimortalidade pela insuficiência renal crônica; Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos:

⌚ Não há relato de efeitos adversos fetais com o uso de sacarato de hidróxido férrico em doses usuais durante a gravidez. Entretanto, caso engravide, o médico deverá ser avisado;

⌚ Os efeitos adversos já relatados são os seguintes: dor no local de administração, alteração da coloração da pele, dor no quadrante inferior abdominal, dor de cabeça, dores no corpo, taquicardia, calorões, náuseas, vômitos, falta de ar, tonturas;

⌚ Possibilidade de reações tardias (em relação à administração) tais como tontura, desmaio, febre, calafrios, vermelhidão, coceiras, dores pelo corpo, confusão mental;

⌚ Possibilidade de reação anafilática grave com morte (1 para cada 4 milhões de doses administradas)

⌚ Medicamento está contraindicado em casos de hipersensibilidade (alergia), em hemocromatose, talassemia, anemia falciforme, anemia hemolítica e anemia associada a leucemias;

⌚ Risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem.

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não queira ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que continuarei a ser atendido(a), inclusive se desistir de usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazer uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que assegurado o anonimato.

() Sim () Não

Nome do paciente: _____		Data do Atendimento: ____ / ____ / ____	
Nome do responsável: _____		Doc. Identificação: _____	
Assinatura do paciente ou do responsável legal			
Médico Responsável: _____		CRM: _____	UF: _____
Assinatura e carimbo do médico			

Observação: Este Termo é obrigatório ao se solicitar o fornecimento de medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e deverá ser preenchido em duas vias: uma será arquivada na farmácia, e a outra, entregue ao usuário ou ao seu responsável legal.



FORMULÁRIO MÉDICO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS - TRATAMENTO DE ANEMIA NA DOENÇA RENAL CRÔNICA

Data do Atendimento: ____/____/____

Nome do Paciente: _____ Idade: _____

Médico Responsável: _____ CRM: _____ UF: _____

CID-10: () N18.0 ou () N18.8

Medicamento Solicitado: _____

POR DEFICIÊNCIA DE ALFAEPOETINA PORTARIA SAS/MS Nº 365 DE 15/02/2017

Diagnóstico de doença renal crônica (DRC) e as condições 1+2+3 + (4 ou 5), assinar abaixo:

- () 1. DRC nos estágios 3-5 (taxa de filtração glomerular estimada (TFG) < 60 mL/min por 1,73 m²).
- () 2. Anemia com Hemoglobina ≤ 10 g/dL (adultos) ou < 11 g/dL (pacientes pediátricos até 18 anos).
- () 3. Índice de Saturação da Transferrina (IST) > 20 %.
- () 4. Hemodiálise com Ferritina > 200 ng/mL.
- () 5. Tratamento Conservador ou Diálise Peritoneal com Ferritina > 100 ng/mL.

Anexar: Creatinina (validade: semestral); Hemoglobina (validade: mensal); Ferritina (validade: trimestral); Índice de Saturação da Transferrina (IST) (validade: trimestral).

POR DEFICIÊNCIA DE SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO - PORTARIA SAS/MS Nº 365 DE 15/02/2017

Diagnóstico de doença renal crônica (DRC) e as condições 1+2+(3 ou 4 ou 5 ou 6) conforme assinalado abaixo:

- () 1. DRC nos estágios 3-5 (taxa de filtração glomerular estimada (TFG) <60 mL/min por 1,73m²). ()
- () 2. Anemia com hemoglobina <10 g/dL.
- () 3. Tratamento conservador ou diálise peritoneal com ferritina <100 ng/mL e índice de saturação da transferrina (IST) <20% (deficiência absoluta).
- () 4. Tratamento conservador ou diálise peritoneal com ferritina entre 100 e 500 ng/mL e índice de saturação da transferrina (IST) <20% (deficiência relativa).
- () 5. Hemodiálise com ferritina <200 ng/mL e índice de saturação da transferrina (IST) <20% (deficiência absoluta).
- () 6. Hemodiálise com ferritina entre 200 e 500 ng/mL e índice de saturação da transferrina (IST) <20% (deficiência relativa)

Anexar: Creatinina (validade: semestral); hemoglobina (validade: mensal); ferritina (validade: trimestral); índice de saturação da transferrina (IST) - (calculável pelo ferro sérico e pela capacidade total de ligação do ferro - validade: trimestral).

PACIENTES PEDIÁTRICOS ATÉ 18 ANOS

Diagnóstico de doença renal crônica (DRC) e as condições 1+2+3, conforme assinalado abaixo:

- () 1. DRC nos estágios 3-5 (TFG <60 mL/min por 1,73m²).
- () 2. Anemia com hemoglobina <10 g/dL.
- () 3. Ferritina <200 ng/mL e índice de saturação da transferrina (IST) <20%.

Anexar: Creatinina (semestral); hemoglobina (mensal); ferritina (trimestral); IST (trimestral).

Declaro para fins de solicitação dos medicamentos Alfaepoetina e ou Sacarato de Hidróxido Férrico para o tratamento de Anemia na Doença Renal Crônica, que o (a) paciente não apresenta nenhum critério de exclusão para uso do ou do(s) medicamento(s) indicado(s).

Assinatura e carimbo do(a) médico(a)

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologias em Saúde

Diretoria de Assistência Farmacêutica

Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada

TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE
DISTÚRBIO MINERAL ÓSSEO NA DOENÇA RENAL CRÔNICA
Calcitriol, Paricalcitol, Cinacalcete, Sevelâmer e Desferroxamina

Eu, _____ (nome do(a) paciente), declaro ter sido informado(a) claramente sobre os benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso dos medicamentos calcitriol, paricalcitol, cinacalcete, desferroxamina e sevelâmer, indicados para o tratamento do Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica. Os termos médicos foram explicados e todas as minhas dúvidas foram resolvidas pelo médico _____ (nome do médico que prescreve).

Assim declaro que fui claramente informado(a) de que o medicamento que passo a receber pode trazer os seguintes benefícios:

- ⌚ Normalização dos parâmetros bioquímicos do metabolismo mineral e ósseo;
- ⌚ Redução nos níveis de fósforo no sangue; - melhora dos sintomas da doença;
- ⌚ Redução de necessidade de retirada da glândula paratireoide;
- ⌚ Redução do risco de fraturas e incidência de eventos cardiovasculares;
- ⌚ Para a desferroxamina: regressão dos sinais e sintomas de intoxicação por alumínio. Fui também claramente informado a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos:
- ⌚ Não se sabe ao certo os riscos do uso desses medicamentos na gravidez, portanto, caso engravide, devo avisar imediatamente ao meu médico;

⌚ A segurança para o uso dos medicamentos calcitriol, paricalcitol e cinacalcete durante a amamentação deve ser avaliada pelo médico assistente considerando riscos e benefícios, visto que podem ser excretado pelo leite materno;

⌚ Efeitos adversos do calcitriol e paricalcitol: aumento dos níveis de cálcio no sangue, prisão de ventre, diarreia, secura da boca, dor de cabeça, sede intensa, aumento da frequência ou da quantidade de urina, perda do apetite, gosto metálico, dor nos músculos, náusea, vômitos, cansaço e fraqueza. Alguns efeitos crônicos podem incluir conjuntivite, diminuição do desejo sexual, irritabilidade, coceiras, infecções do trato urinário, febre alta, aumento da pressão arterial, batimentos cardíacos irregulares, aumento da sensibilidade dos olhos à luz ou irritação, aumento dos níveis de fósforo no sangue, aumento do colesterol, aumento das enzimas do fígado ALT e AST, perda de peso, inflamação no pâncreas e psicose, que é o sintoma mais raro.

⌚ Efeitos adversos do cinacalcete: náusea, vômitos, diarreia, dor abdominal, prisão de ventre, reações de hipersensibilidade, problemas na pele, dores musculares, diminuição ou falta de apetite, convulsões, tonturas, dormências, dor de cabeça, pressão baixa, infecção respiratória, falta de ar, tosse, agravamento da insuficiência cardíaca, diminuição do cálcio e aumento do potássio no sangue.

⌚ Efeitos adversos da desferroxamina: reações no local de aplicação da injeção (dor, inchaço, coceira, vermelhidão), urina escura, vermelhidão da pele, coceira, reações alérgicas, visão borrada, catarata, zumbidos, tontura, dificuldade para respirar, desconforto abdominal, diarreia, câibra nas pernas, aumento dos batimentos do coração, febre, retardo no crescimento (em pacientes que começam tratamento antes dos 3 anos de vida), distúrbio renal e suscetibilidade a infecções.

⌚ Efeitos adversos do sevelâmer: diarreia, vômitos, náusea, gases, má digestão, azia, aumento ou diminuição da pressão arterial, tosse, dor de cabeça, infecções e dor.

⌚ Medicamentos são contraindicados em casos de hipersensibilidade (alergia) conhecida ao fármaco,

⌚ Risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem.

Estou ciente de que esse medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não queira ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que continuarei sendo atendido, inclusive em caso de desistir de usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazer uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que assegurado o anonimato. () Sim () Não

O meu tratamento constará do(s) seguinte(s) medicamento(s):

() calcitriol () paricalcitol () cinacalcete () desferroxamina () sevelâmer

Local: _____		Data: ____/____/____
Nome do paciente: _____		
Cartão Nacional de Saúde: _____	CPF do paciente: _____	
Nome do responsável legal: _____	Doc. Ident. _____	
Assinatura do paciente ou do responsável legal		
Médico Responsável: _____	CRM: _____	UF: _____
Assinatura e carimbo do médico		



**FORMULÁRIO DE ACESSO AOS MEDICAMENTOS PARA DISTÚRBO MINERAL E ÓSSEO
NA DOENÇA RENAL CRÔNICA - PORTARIA CONJUNTA Nº 15, de 04 de AGOSTO de 2022**

Data do Atendimento: ____/____/____

Nome do Paciente: _____ Idade: _____

Serviço: _____ Cidade: _____

Médico Responsável: _____ CRM: _____ UF: ____

MARCAR COM UM X O(OS) MEDICAMENTO(OS) PRESCRITO E OS CRITÉRIOS DE ACORDO COM O PCDT:

PARA SEVELÂMER PACIENTES ADULTOS: ()

Tratamento da hiperfosfatemia com quelantes não à base de cálcio

- () DRC em fase não dialítica com níveis de fósforo acima de 4,5 mg/dL;
 - () DRC em fase dialítica com níveis de fósforo acima de 5,5 mg/dL; ou
 - () Pacientes com contraindicação ao uso de quelantes a base de cálcio.
- *Anexar: Creatinina (semestral); Fósforo (mensal); Cálcio Total (mensal) OU PTH (trimestral).

PARA SEVELÂMER PACIENTES PEDIÁTRICOS ATÉ 18 ANOS: ()

- () 1. DRC estágios 2 a 4 não dialítica com níveis de fósforo acima dos limites normais para a faixa etária e com cálcio sérico corrigido para albumina normal ou acima do normal com ou sem uso de quelantes à base de cálcio; ou
Anexar: Creatinina (semestral); Fósforo (estágios 2 e 3: anual; estágio 4: semestral); Cálcio Total (estágios 2 e 3: anual; estágio 4: semestral).
- () 2. DRC estágios 5 não dialítica ou em diálise com níveis de fósforo acima de 6,0 mg/dL (1 a 12 anos) e acima de 5,5 mg/dL (12 a 18 anos) e com cálcio sérico corrigido para albumina normal ou acima do normal, com ou sem uso de quelantes à base de cálcio.
Além dos critérios acima, os pacientes devem estar em acompanhamento com nutricionista
*Anexar: Creatinina (semestral); Fósforo (trimestral para não dialítico e mensal para dialítico); Cálcio Total (trimestral para não dialítico e mensal para dialítico).

PARA O MEDICAMENTO CALCITRIOL : ()

- () Crianças com DRC estágios 2 a 5D com níveis séricos de PTH acima do limite superior da normalidade;
 - () Adultos portadores de DRC estágio 3A a 5 com níveis séricos de PTH acima dos valores da normalidade;
 - () Pacientes com síndrome da fome óssea após realização de paratireoidectomia;
 - () Pacientes em diálise peritoneal com níveis séricos de PTH acima de 300 pg/mL.
- *Anexar: Creatinina (semestral); Fósforo (trimestral para não dialítico e mensal para dialítico); Cálcio Total (trimestral para não dialítico e mensal para dialítico).

PARA O MEDICAMENTO PARICALCITOL: ()

- () Pacientes adultos com DRC 5D com níveis séricos de PTH igual ou acima de 300 pg/mL e com Cálcio normal, - ou hipocalcemia.
- *Anexar: Creatinina (semestral); Fósforo (trimestral para não dialítico e mensal para dialítico); Cálcio Total (trimestral para não dialítico e mensal para dialítico).



PARA O MEDICAMENTO CINACALCETE: ()

- () 1. Pacientes adultos com DRC em diálise há pelo menos 3 meses, com PTH $\geq$ 300 pg/mL na ausência de hipocalcemia;
- Cálcio $>$ 8,4 mg/dL ou $>$ limite inferior do Valor de Referência (VR).
Anexar: Creatinina (validade: semestral); PTH (validade: trimestral);
Cálcio total (validade: mensal).
- () 2. Pacientes transplantados renais com PTH $\geq$ 120 pg/mL;
- () 3. Pacientes transplantados renais com hipercalcemia
*Anexar: Creatinina (semestral); Fósforo (trimestral para não dialítico e mensal para dialítico);
Cálcio Total (trimestral para não dialítico e mensal para dialítico).

PARA O DIAGNÓSTICO OU TRATAMENTO DA INTOXICAÇÃO POR ALUMÍNIO COM DESFERROXAMINA (DFO)

- () - Para realização de teste para diagnóstico de excesso de alumínio: pacientes que apresentam dosagem sérica não estimulada de alumínio elevada (60 a 200 mcg/L) ou sinais e sintomas clínicos sugestivos de intoxicação por alumínio. Deve também ser realizada previamente à paratireoidectomia, quando o paciente tem história de exposição ao alumínio;
- () - Para realização de tratamento da intoxicação alumínica: pacientes elegíveis para o tratamento com DFO são aqueles com diagnóstico de intoxicação alumínica, detectada por depósito de alumínio em biópsia óssea, independentemente do tipo histológico da doença óssea. Além disso, os pacientes sintomáticos com diagnóstico de intoxicação por alumínio após teste positivo com DFO são elegíveis para esse tratamento.

Declaro que o(a) paciente não apresenta nenhum critério de exclusão para o (os) medicamento(s) prescrito (os).

SIM () NÃO ()

- Serão excluídos deste Protocolo pacientes gestantes ou lactantes com DMO-DRC estágios 2 a 5D.
- Também serão excluídos pacientes que apresentarem toxicidade (intolerância, hipersensibilidade ou outro evento adverso) ou contraindicações absolutas ao uso do respectivo medicamento preconizado ou procedimento preconizados neste Protocolo.
- Adicionalmente, serão excluídos do uso do referido medicamento os pacientes que apresentem, pelo menos, um dos seguintes critérios:
- - Para o calcitriol: hiperfosfatemia ou hipercalcemia (nível sérico corrigido para albumina).
- - Para o paricalcitol: hiperfosfatemia ou hipercalcemia, DRC estágios 3 a 5, crianças.
- - Para o cinacalcete: hipocalcemia, DRC estágios 3 a 5, pacientes transplantados renais com hipercalcemia de etiologias não relacionadas ao HPTS.
- - Para a desferroxamina: concentrações séricas de alumínio não estimuladas maiores que 200 mcg/L (risco de neurotoxicidade). Esses pacientes devem ter seu programa de TRS intensificado para diminuição do nível de alumínio antes de receber a DFO.

Assinatura e carimbo do(a) médico(a)

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde - SAFTEC

Diretoria de Assistência Farmacêutica – DASF

Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada - COAFE

**TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE
Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
Ciclofosfamida, Ciclosporina e Tacrolimo**

Eu, _____ (nome do(a) paciente), declaro ter sido informado(a) claramente sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso de ciclofosfamida, ciclosporina, enalapril, losartana, metilprednisolona, prednisona e tacrolimo, indicados para o tratamento da síndrome nefrótica primária em crianças e adolescentes. Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas foram resolvidas pelo médico _____ (nome do médico que prescreve).

Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o(s) medicamento(s) que passo a receber pode(m) trazer as seguintes melhoras:

c Melhora dos sintomas e sinais do “estado nefrótico”;

c Diminuição da quantidade de proteínas na urina;

c Prevenção da insuficiência renal aguda e da insuficiência renal crônica progressiva. Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos do uso destes medicamentos:

c Ciclosporina e tacrolimo: medicamentos classificados na gestação como fator de risco C (estudos em animais mostraram anormalidades nos descendentes, porém não há estudos em humanos; o risco para o bebê não pode ser descartado, mas um benefício potencial pode ser maior do que os riscos);

c Ciclofosfamida: medicamento classificado na gestação como fator de risco X (seu uso é contraindicado para gestantes ou para mulheres planejando engravidar);

c Efeitos adversos mais comuns da ciclofosfamida: náusea, vômitos, queda de cabelo, risco aumentado de infecções, anemia, toxicidade para medula óssea, infecções na bexiga, risco de sangramento (redução do número de plaquetas), risco de infertilidade;

c Efeitos adversos mais comuns da ciclosporina: problemas nos rins e no fígado, tremores, aumento da quantidade de pelos no corpo, pressão alta, crescimento da gengiva, aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos, formigamentos, dor no peito, batimentos rápidos do coração, convulsões, confusão, ansiedade, depressão, fraqueza, dores de cabeça, unhas e cabelos quebradiços, coceira, espinhas, náusea, vômitos, perda de apetite, soluços, inflamação na boca, dificuldade para engolir, sangramentos, inflamação do pâncreas, prisão de ventre, desconforto abdominal, diminuição das células brancas do sangue, linfoma, calorões, aumento da quantidade de cálcio, magnésio e ácido úrico no sangue, toxicidade para os músculos, problemas respiratórios, sensibilidade aumentada à temperatura e aumento das mamas; Efeitos adversos mais comuns do tacrolimo: tremores, dor de cabeça, diarreia, pressão alta, náusea, disfunção renal, dor no peito, pressão baixa, palpitações, formigamentos, falta de ar, amarelão, diarreia, prisão de ventre, vômitos, diminuição do apetite, azia, dor no estômago, gases, hemorragia, dano hepático, agitação, ansiedade, convulsão, depressão, tontura, alucinações, incoordenação motora, psicose, sonolência, neuropatia, queda de cabelo, aumento da quantidade de pelos no corpo, vermelhidão de pele, coceiras, anemia, aumento ou diminuição das células brancas do sangue, diminuição das plaquetas do sangue, distúrbios na coagulação, síndrome hemolítico-urêmica, edema periférico, alterações metabólicas (hipo ou hiperpotassemia, hiperglicemia, hipomagnesemia, hiperuricemia), diabetes mellito, elevação de enzimas hepáticas, toxicidade renal, diminuição relevante do volume da urina, febre, acúmulo de líquido no abdômen e na pleura, fraqueza, dor lombar, osteoporose, dores no corpo, peritonite, fotossensibilidade, alterações visuais;

Estou ciente de que o(s) medicamento(s) somente pode(m) ser utilizado(s) por mim, comprometendome a devolvê-lo(s) caso não queira ou não possa utilizá-lo(s) ou se o tratamento for interrompido.

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que assegurado o anonimato. () Sim () Não

Meu tratamento constará do(s) seguinte(s) medicamento(s):

() ciclofosfamida () ciclosporina () tacrolimo

Local: _____		Data: ____ / ____ / ____	
Nome do paciente: _____		Cartão SUS Nº: _____	
Nome do responsável legal: _____			
_____ Assinatura do paciente ou do responsável legal			
Médico Responsável: _____	CRM: _____	UF: _____	
_____ Assinatura e carimbo do médico			

Observação: Este Termo é obrigatório ao se solicitar o fornecimento de medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e deverá ser preenchido em duas vias: uma será arquivada na farmácia, e a outra, entregue ao usuário ou ao seu responsável legal.

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde - SAFTEC

Diretoria de Assistência Farmacêutica – DASF

Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada - COAFE

FORMULÁRIO DE ACESSO - SÍNDROME NEFRÓTICA PRIMÁRIA EM CRIANÇAS**PORTARIA CONJUNTA Nº 01, DE 10 DE JANEIRO DE 2018**

Nome do Paciente: _____ Data do atendimento: ____/____/____

Médico Responsável: _____ CRM: _____ UF: _____

1. Classificar paciente de acordo com a resposta ao tratamento:

- ☐ Tratamento inicial
- ☐ Recidivas frequentes em altas doses/dependência de corticosteroide
- ☐ Síndrome nefrótica resistente ao corticosteroide (**anexar biópsia renal**)
- ☐ Paciente em remissão completa com o uso de corticoides mas apresenta efeitos adversos
- ☐ Paciente em remissão parcial ao uso de corticoides

2. Selecionar, dentre os critérios listados, aqueles que o paciente apresenta:

- ☐ Proteinúria acima de 50 mg/kg/dia ou acima de 40 mg/m² /h ou acima de 3,5 g/24 h/1,73 m² ou índice proteinúria/creatininúria (IPC) acima de 2,0; (**anexar dosagem de proteinúria de 24 horas ou proteinúria de amostra isolada**)
- ☐ Albumina sérica abaixo de 2,5 g/dL; (**anexar dosagem de albumina sérica**)
- ☐ Colesterol total igual ou acima de 240 mg/dL ou triglicerídeos igual ou acima 200 mg/dL (**anexar dosagem de colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos**)

3. Informe se o paciente faz ou fez uso recente dos seguintes medicamentos:

- Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)
- Sais de ouro
- Penicilamina
- Captopril

☐ Sem uso recente dos medicamentos acima.☐ Uso recente – especificar: _____

4. Critérios Excludentes – Causas Secundárias

- ☐ HBsAg – Negativo
- ☐ Sorologia para toxoplasmose – Negativa
- ☐ Anti-HCV – Negativo
- ☐ Anti-HIV – Negativo
- ☐ Fator antinuclear (FAN) – Negativo

Assinatura e carimbo do médico



TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE

LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO

AZATIOPRINA, CICLOFOSFAMIDA, CICLOSPORINA, CLOROQUINA, DANAZOL, HIDROXICLOROQUINA, METOTREXATO, MICOFENOLATO DE MOFETILA, E TALIDOMIDA

Eu, _____ (nome do (a) paciente), declaro ter sido informado(a) claramente sobre os benefícios, riscos, contraindicações, principais efeitos adversos relacionados ao uso de cloroquina, hidroxiclороquina, metilprednisolona, azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida, danazol, metotrexato e talidomida, indicados para o tratamento de lúpus eritematoso sistêmico. Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas foram resolvidas pelo médico _____ (nome do médico que prescreve). Expresso também minha concordância e espontânea vontade em submeter-me ao referido tratamento, assumindo a responsabilidade e os riscos por eventuais efeitos indesejáveis. Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que os medicamentos que passo a receber podem trazer as seguintes melhoras:

⌚ Melhora dos sintomas;

⌚ Prevenção de complicações associadas com a doença. Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos:

⌚ **Cloroquina e hidroxiclороquina**, ciclosporina e metilprednisolona - medicamentos classificados na gestação como fator de risco C (estudos em animais mostraram anormalidades nos descendentes, porém não há estudos em humanos; o risco para o bebê não pode ser descartado, mas um benefício potencial pode ser maior que os riscos);

⌚ **Azatioprina**: medicamento classificado na gestação como fator de risco D (há evidências de riscos ao feto, mas um benefício potencial pode ser maior que os riscos);

⌚ **Ciclofosfamida, danazol, metotrexato e talidomida**: medicamentos classificados na gestação como fator de risco X (seu uso é contraindicado para gestantes ou mulheres planejando engravidar):.

⌚ **Cloroquina e hidroxiclороquina**: principais reações adversas são usualmente relacionadas com a dose e o tempo de tratamento; problemas nos olhos, como visão borrada, ou qualquer alteração na visão, diminuição das células brancas e vermelhas do sangue, alterações emocionais, problemas para escutar, convulsões, problemas no coração, problemas nos músculos dos cílios, causando dificuldade para ler, diarreia, perda de apetite, náusea, dor no estômago, vômito, dor de cabeça, coceira, descoloração e queda de cabelo, descoloração da pele, das unhas ou no interior na boca, tontura, nervosismo, inquietação, vermelhidão, problemas de pele;

⌚ **Azatioprina**: diminuição das células brancas, vermelhas e plaquetas do sangue, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, fezes com sangue, problemas no fígado, febre, calafrios, diminuição de apetite, vermelhidão de pele, perda de cabelo, aftas, dores nas juntas, problemas nos olhos (retinopatia), falta de ar, pressão baixa;

⌚ **Ciclofosfamida**: diminuição do número de células brancas no sangue, fraqueza, náusea, vômito, infecções da bexiga acompanhada ou não de sangramento, problemas nos rins, no coração, pulmão, queda de cabelos, aumento do risco de desenvolver cânceres.

⌚ **Ciclosporina**: problemas nos rins e fígado, tremores, aumento da quantidade de pelos no corpo, pressão alta, aumento do crescimento da gengiva, aumento do colesterol e triglicerídios, formigamentos, dor no peito, batimentos rápidos do coração, convulsões, confusão, ansiedade, depressão, fraqueza, dores de cabeça, unhas e cabelos quebradiços, coceira, espinhas, náuseas, vômitos, perda de apetite, soluços, inflamação na boca, dificuldade para engolir, sangramentos, inflamação do pâncreas, prisão de ventre, desconforto abdominal, diminuição das células brancas do sangue, linfoma, calorões, aumento da quantidade de cálcio, magnésio e ácido úrico no sangue, toxicidade para os músculos, problemas respiratórios, sensibilidade aumentada a temperatura, aumento das mamas;

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologias em Saúde

Diretoria de Assistência Farmacêutica

Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada

⌚ **Danazol:** reações adversas mais comuns incluem náuseas, vômitos, diarreia, dor de cabeça, nervosismo, desorientação, fraqueza, convulsões, ganho de peso, inchaço, alterações do paladar, aumento da pressão arterial, perda de potássio, insuficiência cardíaca congestiva;

⌚ **Metotrexato:** pode causar problemas gastrointestinais com ou sem sangramento, diminuição do número de glóbulos brancos no sangue, diminuição do número de plaquetas, aumento da sensibilidade da pele aos raios ultravioletas, feridas na boca, inflamação nas gengivas, inflamação na garganta, espinhas, perda do apetite, náusea, palidez, coceira, vômitos; mais raramente e dependendo da dose utilizada, podem ocorrer cansaço associado à formação de bolhas e com perda de regiões da pele e de mucosas (síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica) e problemas graves de pele; também pode facilitar o estabelecimento ou agravar infecções;

⌚ **Talidomida:** reação adversa mais importante é a teratogenicidade, ou seja, causa graves defeitos no corpo dos bebês de mulheres que o utilizam na gravidez; também causa sono e problemas nos nervos das extremidades; em casos mais raros, pode causar tremor, fraqueza, tonturas, alterações do humor, prisão de ventre, boca seca, aumento do apetite, inchaço, náuseas, problemas na menstruação;

⌚ Medicamentos contraindicados em casos de hipersensibilidade (alergia) aos fármacos ou aos componentes da fórmula.

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo a devolvê-lo caso não queira ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que continuarei a ser atendido(a), inclusive em caso de desistir de usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que assegurado o anonimato.

() Sim () Não

Meu tratamento constará do seguinte medicamento:

() azatioprina () ciclofosfamida () ciclosporina () cloroquina () danazol () hidroxicloroquina
() metilprednisolona () metotrexato () micofenolato de mofetila () talidomida

Local: _____		Data: ____ / ____ / ____	
Nome do paciente: _____		Cartão SUS: _____	
Nome do responsável legal: _____		ID: _____	
_____ Assinatura do paciente ou do responsável legal			
Médico Responsável: _____		CRM: _____	UF: _____
_____ Assinatura e carimbo do médico			

Observação: Este Termo é obrigatório ao se solicitar o fornecimento de medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e deverá ser preenchido em duas vias: uma será arquivada na farmácia, e a outra, entregue ao usuário ou ao seu responsável legal.



FORMULÁRIO PARA ACESSO AOS MEDICAMENTOS DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO

PORTARIA CONJUNTA Nº 21, de 01 de NOVEMBRO de 2022.

Obs.: o preenchimento deste formulário não é obrigatório. Caso prefira, o médico poderá descrever os critérios de inclusão em relatório médico (conforme PCDT de Lúpus eritematoso sistêmico)

Nome do Paciente: _____ Data de Nasc. ____/____/____
Cartão SUS Nº _____ Nº do CPF: _____
Médico Assistente: _____ CRM nº _____ UF: _____
Data: ____/____/____ Local/ serviço: _____

Assinalar CID do paciente:

L93.0 Lúpus Discoide ()

L93.1 Lúpus cutâneo subagudo ()

M32.1 Lúpus eritematoso disseminado (sistêmico) com comprometimento de outros órgãos e sistemas ()

M32.8 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado (sistêmico) ()

Critérios de classificação ACR para LES - O diagnóstico é estabelecido a partir da presença de pelo menos 4 dos 11 critérios de classificação, de acordo com o PCDT.

OBS.: Para os itens 7, 9, 10 e 11, devem ser anexados exames que comprovem as respectivas alterações.

Assinalar os critérios apresentados pelo paciente:

() 1.Eritema malar: eritema fixo, plano ou elevado nas eminências malares, poupando a região nasolabial.

() 2.Lesão discoide: lesão eritematosa, infiltrada, com escamas queratóticas aderidas e tampões foliculares, que evolui com cicatriz atrófica e discromia.

() 3.Fotosensibilidade: eritema cutâneo resultante de reação incomum ao sol, por história do paciente ou observação do médico.

() 4.Úlcera oral: ulceração oral ou nasofaríngea, geralmente não dolorosa, observada pelo médico.

() 5.Artrite: artrite não erosiva envolvendo 2 ou mais articulações periféricas, caracterizada por dor à palpação, edema ou derrame.

() 6.Serosite: a) pleurite – história convincente de dor pleurítica ou atrito auscultado pelo médico ou evidência de derrame pleural; ou b) pericardite – documentada por eletrocardiografia ou atrito ou evidência de derrame pericárdico.

() 7.Alteração renal: a) proteinúria persistente de mais de 0,5 g/dia ou acima de 3+ (+++) se não quantificada; ou b) cilindros celulares – podem ser hemáticos, granulares, tubulares ou mistos.

() 8.Alteração neurológica: a) convulsão – na ausência de fármacos implicados ou alterações metabólicas conhecidas (por exemplo, uremia, cetoacidose, distúrbios hidroeletrólíticos); ou b) psicose – na ausência de fármacos implicados ou alterações metabólicas conhecidas (por exemplo, uremia, cetoacidose, distúrbios hidroeletrólíticos).

() 9.Alterações hematológicas: a) anemia hemolítica com reticulocitose; ou b) leucopenia de menos de 4.000/mm³ em duas ou mais ocasiões; ou c) linfopenia de menos de 1.500/mm³ em duas ou mais ocasiões; ou d) trombocitopenia de menos de 100.000/mm³ na ausência de uso de fármacos causadores.

() 10.Alterações imunológicas: a) presença de anti-DNA nativo; ou b) presença de anti-Sm; ou c) achados positivos de anticorpos antifosfolípidios baseados em concentração sérica anormal de anticardiolipina IgG ou IgM, em teste positivo para anticoagulante lúpico, usando teste-padrão ou em VDRL falsopositivo, por pelo menos 6 meses e confirmado por FTA-Abs negativo.

() 11.Anticorpo antinuclear (FAN): título anormal de FAN por imunofluorescência ou método equivalente em qualquer momento, na ausência de fármacos sabidamente associados ao lúpus induzido por fármacos.

ATENÇÃO: Para os critérios assinalados, necessário encaminhar exames comprobatórios



Critérios SLICC 2012 para Lúpus Eritematoso Sistêmico

De acordo com os critérios SLICC, o paciente pode ser classificado como com LES quando apresentar, pelo menos, quatro dos critérios a seguir, incluindo pelo menos um critério clínico e um critério imunitário ou se apresentar biópsia renal compatível com nefrite lúpica na presença de FAN ou anticorpos anti-dsDNA. Os critérios, são cumulativos e não necessitam ser concomitantes.

Critérios clínicos

() **Lúpus cutâneo agudo:** eritema malar (não é contabilizado se for lesão discoide), lúpus bolhoso, variante com necrose epidérmica tóxica, eritema maculopapular, eritema fotossensível (na ausência de dermatomiosite) ou lúpus cutâneo subagudo (anular policíclico ou psoriasiforme não cicatricial, apesar de poder evoluir com alteração de pigmentação ou teleangiectasias).

() **Lúpus cutâneo crônico:** eritema discóide localizado (acima do pescoço) ou generalizado (acima e abaixo do pescoço), lúpus hipertrófico (verrucoso), paniculite (lúpus profundus), lúpus mucoso, lúpus eritematoso tumidus, eritema pério ou sobreposição de lúpus discoide e líquen plano.

() **Alopecia não cicatricial:** afinamento difuso ou fragilidade capilar com quebra visível de cabelos (na ausência de outras causas, tais como alopecia areata, alopecia androgênica, medicamentos, deficiências vitamínicas ou ferropenia).

() **Úlceras orais ou nasais:** ulcerações geralmente pouco dolorosas localizadas no palato, boca e língua ou úlceras nasais (na ausência de outras causas, tais como vasculites, doença de Behçet, infecções – herpes vírus, doença intestinal inflamatória, artrite reativa, medicamentos ou comidas ácidas).

() **Alterações articulares:** sinovite em duas ou mais articulações, com edema ou derrame articular ou artralgia em duas ou mais articulações e rigidez matinal maior que 30 minutos.

() **Serosites:** dor pleurítica típica por mais de um dia ou derrame pleural ou atrito pleural ou dor pericárdica típica por mais de um dia ou derrame pericárdico ou atrito pericárdico ou eletrocardiograma com sinais de pericardite (na ausência de outras causas, tais como infecção, uremia ou síndrome de Dressler).

() **Alterações renais:** relação entre proteína e creatinina urinárias (ou proteinúria de 24 horas) representando mais de 500 mg de proteínas nas 24 horas ou presença de cilindros hemáticos.

() **Alterações neurológicas:** convulsão, psicose, mononeurite múltipla, mielite, neuropatia periférica ou craniana ou estado confusional agudo (na ausência de vasculites primárias, infecções, distúrbios hidroeletrólíticos, distúrbios metabólicos, uremia, medicamentos, intoxicações ou diabetes melito).

() **Anemia hemolítica:** presença de anemia hemolítica. Leucopenia ou linfopenia: contagem de leucócitos $<4.000/\text{mm}^3$ ou linfopenia $<1.000/\text{mm}^3$, em pelo menos uma ocasião (na ausência de outras causas, tais como síndrome de Felty, medicamentos ou hipertensão portal).

() **Trombocitopenia:** contagem de plaquetas $<100.000/\text{mm}^3$ em pelo menos uma ocasião (na ausência de outras causas, tais como medicamentos, hipertensão portal ou púrpura trombocitopênica trombótica).

Critérios imunológicos:

() **Fator Antinuclear:** fator antinuclear acima do valor de referência

() **Anti-Sm:** anticorpo anti-Sm positivo.

() **Antifosfolípidos:** qualquer um dos seguintes: anticoagulante lúpico positivo; VDRL falso-positivo; anticardiolipinas (IgA, IgG ou IgM) em títulos moderados ou altos ou anti-beta 2-glicoproteína 1 (IgA, IgG ou IgM) positivo

() **Complementos reduzidos** (abaixo do limite inferior da normalidade de acordo com a técnica do laboratório): frações C3, C4 ou CH50

() **Coombs direto:** Coombs direto positivo (na ausência de anemia hemolítica).

Fonte: Systemic Lupus International Collaborating Clinics³⁶.



CrITÉRIOS EULAR/ACR 2019 para LÚPUS ERMATEMATOSO SISTÊMICO

O paciente pode ser classificado como com LES se tiver pontuação ≥ 10 , sendo que, em cada domínio, deve ser utilizada a maior pontuação. Ainda, é condição necessária a positividade de FAN $\geq 1:80$.

Domínio Constitucional	Pontuação	Domínio Hematológico	Pontuação
Febre	2	Leucopenia	3
Domínio Cutâneo		Plaquetopenia	4
Alopecia não cicatricial	2	Hemólise autoimune	4
Úlceras orais	2	Domínio renal	
Lúpus cutâneo subagudo ou Lúpus Eritematoso Discoide	4	Proteinúria $\geq 0,5$ g/24 horas	4
Lúpus cutâneo agudo	6	Biópsia renal classe II ou nefrite lúpica classe V	8
Domínio articular		Biópsia renal classe III ou nefrite lúpica classe IV	10
Sinovite ou dor à palpação ≥ 2 articulações e rigidez matinal ≥ 30 minutos	6	Domínio dos anticorpos antifosfolipídicos	
Domínio neurológico		aCL (IgG > 400 PL ou anti-B2GPI IgG > 40 ou LAC+)	2
Delírio	2	Domínio complemento	
Psicose	3	C3 baixo ou C4 baixo	3
Convulsão	5	C3 e C4 baixos	4
Domínio serosas		Domínio dos anticorpos altamente específicos	
Derrame pleural ou pericárdico	5	Anti-dsDNA	6
Pericardite aguda	6	Anti-Smith	6
TOTAL		TOTAL	

Fonte: European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology³⁸. Legenda: aCL: Anticorpos anticardiolipina; anti-B2GPI: Anticorpos antibeta2 glicoproteína 1; LAC: Anticoagulante lúpico

Informar se o paciente apresenta alguma das condições abaixo:

- | | |
|---|---|
| ☐ Uso concomitante de primaquina | ☐ Hipertensão não controlada |
| ☐ Lactação | ☐ Porfiria |
| ☐ Concepção | ☐ Sangramento uterino anormal |
| ☐ Gestação | ☐ Elitismo |
| ☐ Maculopatia associada aos antimaláricos | ☐ Úlcera péptica ativa |
| ☐ Neoplasia maligna em atividade | ☐ Acometimento hepático grave |
| ☐ Tuberculose | ☐ Abuso de drogas |
| ☐ Imunossupressão (aids, linfoma e outros) | ☐ Acometimento renal grave |
| ☐ Doença hematológica grave | ☐ Cirrose |
| ☐ Infecção crônica ativa - Hepatites B ou | ☐ Obstrução do trato urinário |
| ☐ Infecção aguda – Hepatite C | ☐ Nenhuma das condições listadas |

Declaro que este(a) paciente não possui nenhuma contraindicação para uso do medicamento prescrito:

Assinatura e carimbo do médico



Declaração de Residência para solicitação de Medicamentos de Terceiros por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF

Eu (Proprietário Residencial), _____, portador (a) do CPF Nº _____, ou Identidade Nº _____, declaro que (nome do(a) paciente) _____, portador do Cartão SUS Nº _____ e CPF Nº _____ reside no endereço constante no comprovante de residência apresentado, (anexar a cópia do documento, Conta de Luz, ou água etc).

Declaro estar ciente das informações aqui prestadas e que são verdadeiras, dato e assino o presente documento.

Local:(Nome da Cidade)_____ Data: ____/____/____

Assinatura do Declarante

* Anexar comprovante de residência em nome do declarante.

Código Penal - Art. 299 -...Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.